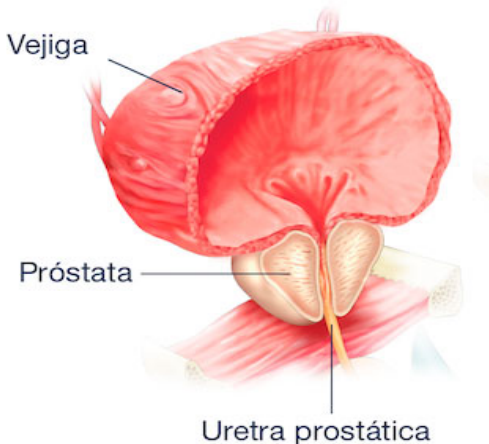




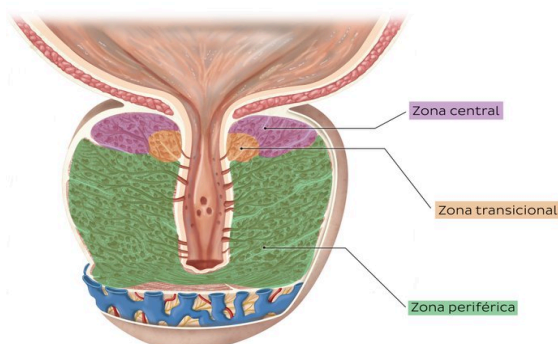
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 5 Semestre 2026A		CÓDIGO:	NIVEL DE PRACTICA.
NOMBRE DEL DOCENTE: Samuel Humberto Palacio Peña		ESCENARIO DE PRÁCTICA:	NOTA:
ESPECIALIDAD: Urología	CIRUJANO	FECHA:	
NOMBRE DEL PACIENTE:		NÚMERO HISTORIA CLÍNICA:	EDAD DEL PX:
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO PARA REALIZAR: prostatectomía radical con linfadenectomía			
PROCESO DE INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA			
1. ETAPA DE PLANEACIÓN:			
1.1. Objetivo quirúrgico (Hacer descripción) Realizar la resección completa de la próstata y vesículas seminales asociada a linfadenectomía pélvica, con el fin de lograr control oncológico local, estadificación ganglionar adecuada y disminución del riesgo de progresión tumoral.			
1.2. Anatomía y fisiología (Hacer gráfico y descripción) ANATOMIA 			



Es una glándula accesoria del sistema reproductor masculino. Es del tamaño de una nuez, y se localiza alrededor de la porción prostática de la uretra (uretra prostática). Anatómicamente, la próstata está compuesta por un istmo, un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo.

1. **ISTMO:** Se encuentra anterior a la uretra. Está compuesto principalmente por tejido fibroso y muscular, con poco o nulo tejido glandular.
2. **LOBULO IZQUIERDO Y DERECHO:** Están separados anteriormente por el istmo, y posteriormente por un surco longitudinal que se extiende sobre la línea media de la cara posterior de la próstata. Cada lóbulo está dividido en cuatro lobulillos, con base en sus relaciones anatómicas con el conducto eyaculador y la uretra prostática, que son los siguientes:
 - Lobulillo inferoposterior: inferior a la uretra y posterior al conducto eyaculador.
 - Lobulillo inferolateral: posicionado lateralmente a la uretra.
 - Lobulillo superomedial: por debajo del lobulillo inferoposterior y alrededor del conducto eyaculador.
 - Lobulillo anteromedial: inferior al lobulillo inferolateral y lateral a la porción proximal de la uretra prostática.

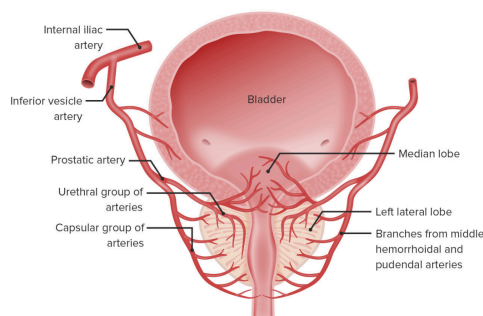
La próstata consta a su vez de una base, vertice, cara anterior, cara posterior y unas caras inferolaterales. Y a su vez se divide en zonas: una zona central, una zona periférica, zona transicional y estroma fibromuscular anterior



1. **Zona central:** se encuentra en la base de la próstata, envolviendo los conductos eyaculadores y se conforma por las glándulas submucosas periuretrales
2. **Zona transicional:** es corta y rodea la porción proximal de la uretra prostática superior al colículo seminal, está formada por las glándulas mucosas periuretrales.
3. **Zona periférica:** Se compone por las glándulas prostáticas principales



VASCULARIZACION



La fuente principal de irrigación arterial de la próstata es:

- Arteria pudenda interna, con algunas contribuciones adicionales de las arterias vesical inferior y rectal media

INERVACION

Esta inervada por las fibras parasimpáticas de los nervios espláncnicos pélvicos del plexo prostático, que reciben sus fibras del plexo hipogástrico inferior (para erección y efecto secretomotor de acinos), el plexo hipogástrico inferior a su vez recibe fibras simpáticas preganglionares del plexo hipogástrico superior para brindar inervación motora a los músculos lisos del estroma glandular (para eyaculación y contracción muscular lisa).

FISIOLOGIA

Su función es la de producir el fluido prostático, que, en combinación con el espermatozoides proveniente de los testículos, componen el semen y a su vez la función principal del fluido prostático es activar a las células espermáticas, por lo que asiste en el proceso general de la reproducción.

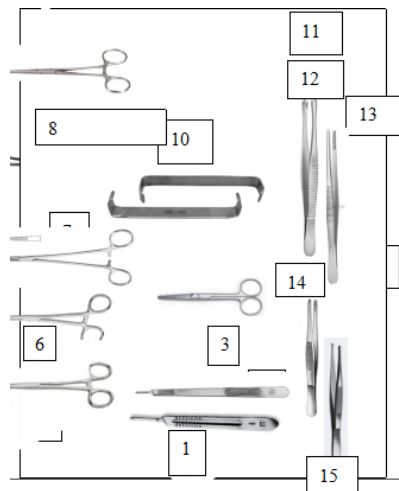


1.3. Lista de chequeo:

INSTRUMENTAL	EQUIPOS / DISPOSITIVOS MEDICO	SUTURAS Y AGUJAS	FARMACOS Y SOLUCIONES
Canasta general Canasta Vascular Pinza hemolock de 10 Pinza hemolock de 5 Espátula larga para electrobisturí Tijera de metzenbaum extralarga Manubrios Pinza ligacclip	Paquete de ropa general Compresas Sabana Bata accesorio Guantes Sonda Foley 22x30 Gasas Sharpie Tapones para sonda Aseptojeringa Hoja de bisturí 15, 20 Jeringa 20 cc Canula de Yankawer Dren de blake o pen rose	PIEL: Polipropileno 3/0 ACC 3/8 FASCIA: Poliglactina 0 o 1 ACR ½ LECHO PROSTATICO: Catgut cromado 2/0 ACR ½ ANASTOMOSIS: Poliglactina 910 2/0 ACR ½ GANGLIOS LINFATICOS: Ligacclip, seda 2/0 o 3/0 precortada FIJACION DRENES: Seda 2/0	• Solución Salina • Xilocaína Jalea • Azul de metileno Bupivacaina al 0,5 % con epinefrina



1. ETAPA DE ORGANIZACIÓN:



a.

Arreglos de mesas de mayo y reserva (realizar esquema).

1. Mango de bisturí #4 – hoja 20
2. Mango de bisturí #3 largo – hoja 15
3. Tijeras de Metzenbaum
4. Tijera de Mayo



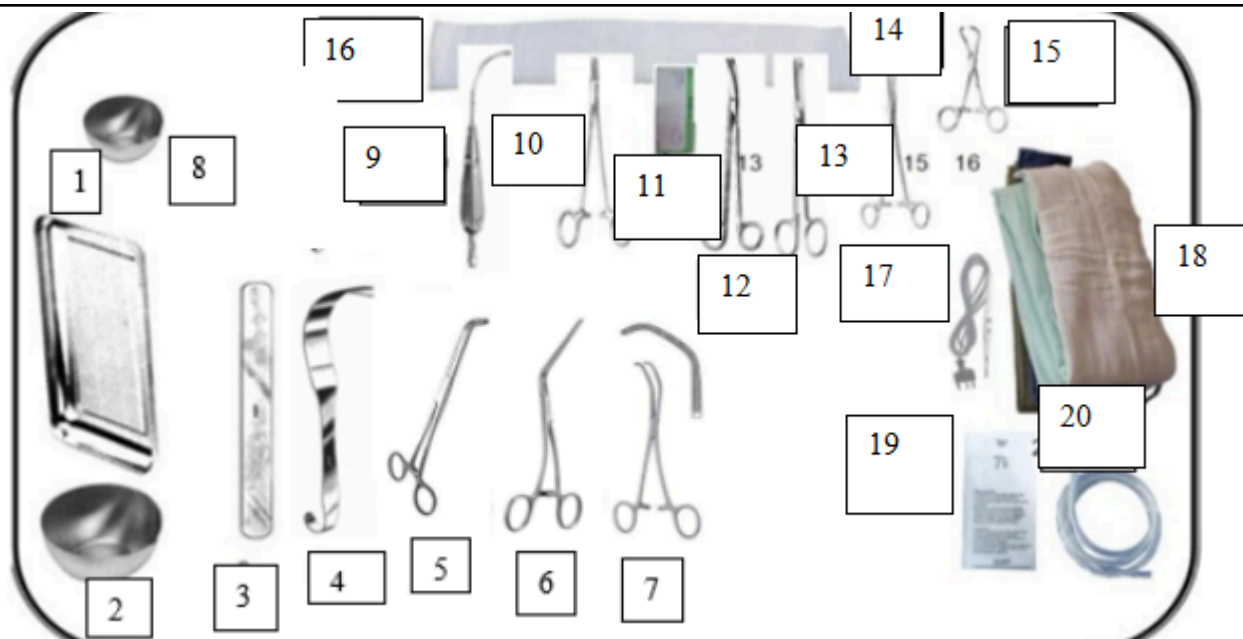
**Universidad
de Santander**
Personería Jur. 810 de 12/03/96 Min.Educación
VIGILADA MINEDUCACIÓN **UDES**

PROGRAMA DE INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA

PLANEAMIENTO QUIRÚRGICO FORMATIVA
IQX-FT-003-BUC

Versión: 1

5. Pinzas Kelly curva
6. Pinzas Kelly recta
7. Pinza Kelly Adson
8. Pinza Rochester curva
9. Pinza Rochester recta
10. Separadores de Farabeuf
11. Pinzas Allix
12. Pinzas de disección rusa
13. Pinza de disección sin garra larga
14. Pinza de disección sin garra corta
15. Pinza de disección con garra corta
16. Pinza Adson con garra

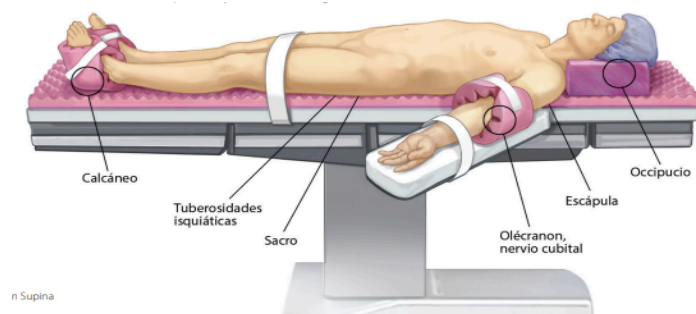


1. Equipo general. 2. Coca. 3. Valva maleable. 4. Separador deaver angosto. 5. Pinzas cístico. 6. Clamp de satinsky. 7. Clamp de debakey . 8. Coca con suero. 9. Canula de yankawer. 10. Portaagujas. 11. Suturas. 12. Tijera de metzenbaum larga. 13. Tijera de mayo larga. 14. Pinza foerster. 15. Pinza de campo. 16. Compresas. 17. Electrobisturi. 18. Paquete de ropa. 19. Guantes. 20. Caucho de succion



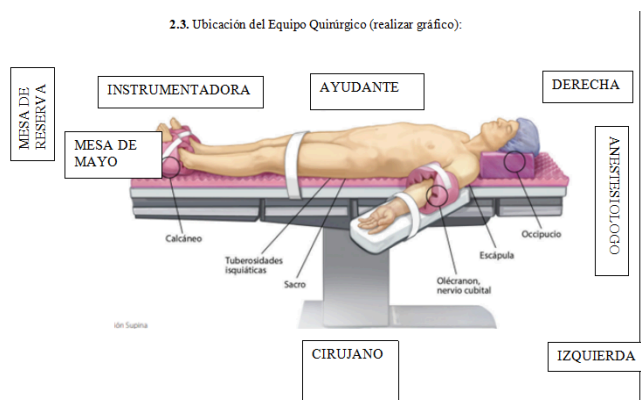
2.2. Posición del paciente (Nombre y gráfico):

Decubuto supino



2.3 Ubicación del Equipo Quirúrgico (realizar gráfico)

2.3. Ubicación del Equipo Quirúrgico (realizar gráfico):



1.

2. ETAPA DE EJECUCION:

a) Anestesia (escribir el tipo de anestesia):



b) Uso de anestesia general o regional

c) Incisión (escribir el tipo de abordaje y el nombre de la incisión):

Incisión mediana infraumbilical



d) Proceso Quirúrgico (Describir los pasos principales de la técnica médico-quirúrgica con el instrumental a usar).

TÉCNICA QUIRÚRGICA	INSTRUMENTACIÓN
Se realiza incisión mediana infraumbilical de la piel, tejido celular subcutáneo	Mango de bisturí 4 con hoja 20
Se realiza hemostasia	Pinza Kelly curva y lapicero del electrobisturi
Se visualiza la fascia	Separadores de farabeuf
Se realiza la divulsión de los músculos y se visualiza la cavidad extraperitoneal	Pinza Kelly curva y separadores deaver anchos
Se realiza la linfadenectomía de vasos iliacos, hipogástricos bilaterales, y aórticos	Pinza Kelly curva, tijeras de metzenbaum, separador de vanea, liga clips, torundas y frasco de patología
Se rechaza la vejiga	Valva maleable
Se diseccionan los vasos superficiales y los ligamentos pubo prostáticos, se clampean y se ligan	Pinza cístico, Kelly adson y poliglactina 910 calibre 0 ½
Se incide una y luego se hace la disección de la fascia endopelvica	Tijeras de metzenbaum
Se clampea la vena dorsal del pene a través de la fascia Endo pélvica	Pinza cístico-larga
Se realiza ligadura	Seda 0 sin aguja

Haciendo sección de la vena dorsal del pene y los ligamentos pubo prostáticos se identifica la uretra	Mango bisturí 3 con hoja 15, tijeras de metzenbaum, disección vascular, pinza cístico y pinza Kelly adson
Se realiza disección de la próstata hacia abajo y se visualiza la unión prostática uretral	Pinza Rochester recta, Torundas
Se realiza sección de la uretra con la sonda se repara, se tracciona la capsula y se lleva hacia atrás	Tijeras finas, sonda foley , pinza cístico
Se realiza liberación de las adherencias de los músculos elevadores del ano y rectales	Pinza foerster, pinza pennington
Se reparan los musculos elevadores del ano	Pinza Kelly curva y poliglactina 910 ACR ½ circulo
Se realiza liberación de la próstata y se corta a nivel del cuello y vejiga	Tijeras de metzenbaum, mango de bisturí 3 largo con hoja de bisturí 15
Se realiza la disección roma en la pared prostática y vejiga para poder encontrar las vesículas seminales	Pinzas Rochester
Se realiza la sección de los conductos deferentes	Tijeras de metzenbaum y torunda
Se realiza la ligadura de los pedículos seminales	Pinza Kelly adson, pinza cistico, sutura natural no absorbible trenzada 2/0
Se realiza la plastia del cuello vesical	Portaagujas largo, pinza de disección larga, catgut cromado 3/0 aguja ½ circulo redonda
Se realiza anastomosis del cuello vesical de la uretra	Portaagujas largo, pinza de disección larga, catgut cromado 2/0 aguja curva ½ circulo redonda
Se coloca una segunda sonda Foley 22X30 y se anudan los reparos anteriores	Jeringa 20 cc, equipo de venoclisis y solución salina
Se deja un dren por contraabertura	Pinzas Rochester
Se realiza hemostasia y recuento	Pinza foerster
Se cierra por planos	Portaagujas mediano, pinza de disección con garra, separadores de Farabeuf, disección adson con garra, sutura sintética absorbible calibre 1 agua ½ circulo redonda, polipropileno 3/0 aguja curva de 3/8 de circulo cortante



**Universidad
de Santander**
Personería Jur. 810 de 12/03/96 Min.Educación
VIGILADA MINEDUCACIÓN **UDES**

PROGRAMA DE INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA

PLANEAMIENTO QUIRÚRGICO FORMATIVA
IQX-FT-003-BUC

Versión: 1

FORMATO DE INFORME SEMANAL DE LA PRACTICA FORMATIVA
FORMATO RECORD DE ASISTENCIA A CIRUGIA - PRACTICA FORMATIVA
IQX-FT-024-UDES

FIRMA ESTUDIANTE: _____

FIRMA DOCENTE: _____